Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Fátima do Sul
2ª Vara

Processo nº 0801055-39.2025.8.12.0010
Classe: Procedimento Comum Cível - Padronizado
Autora: Raquel Costa dos Reis
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Trata-se de *ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência* ajuizada por **Raquel Costa dos Reis** em desfavor do **Estado de Mato Grosso do Sul**. Alegou, em suma, que é acometida da(s) patologia(s) informada(s) na exordial e, por isso, necessita do(s) respectivo(s) medicamento(s). Fez os demais requerimentos de praxe. Juntou documentos.

O NAT exarou parecer às f. 30-39.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao *pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial* (f. 43).

A tutela de urgência foi indeferida (f. 44/47).

O réu contestou às f. 57/64, defendendo a improcedência da demanda.

Impugnação à contestação (f. 68/70).

As partes não pleitearam a produção de outras provas (f. 74 e 77).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Inexistindo-se preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passa-se à análise do mérito.

Pois bem.

O STJ fixou as seguintes teses:

> *ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 19/12/2025 às 16:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801055-39.2025.8.12.0010 e código 2pj09Ba2.

> *EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.* ***4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.*** (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Com o julgamento dos Temas **6** e **1234** da sistemática de repercussão geral pelo STF, restaram fixados critérios estritos para a concessão judicial de medicamentos **não incorporados ao SUS**, ainda que registrados na ANVISA. Dentre os requisitos, destaca-se a necessidade de que a parte autora demonstre, **cumulativamente**:

> *(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;*
>
> *(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia,*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 19/12/2025 às 16:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801055-39.2025.8.12.0010 e código 2pj09Ba2.

acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise." (Tema 6, RE 566.471, STF).

No caso, verifica-se que a incapacidade financeira da parte autora é presumível, assim como os medicamentos postulados estão registrado na ANVISA (f. 37).

Entretanto, o NAT apresentou parecer desfavorável (f. 38/39):

XI - Conclusão favorável ou desfavorável ao pedido.

Considerando que a paciente está sendo atendida por médico do SUS.

Considerando que Aripiprazol, Oxalato de escitalopram e Levomepromazina não estão padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2024).

Considerando que o PCDT da Esquizofrenia, Portaria SAS/MS nº 364 de 09/04/2013, que oferece Olanzapina, Risperidona, Clozapina, Quetiapina, Ziprasidona, haloperidol e decanoato de haloperidol, sendo que a paciente não está cadastrada.

Considerando que a RENAME 2024 tem padronizado no CBAF medicamentos antidepressivos (Amitriptilina, Clomipramina, Nortriptilina, Fluoxetina), ansiolíticos (Clonazepam, Diazepam), antipsicóticos (Clorpromazina, Haloperidol), estabilizador do humor (Carbonato de Lítio), anticonvulsivantes (Carbamazepina, Fenitoína, Fenobarbital, Valproato de Sódio).

Considerando a Política Nacional de Saúde Mental.

Considerando as evidências científicas disponíveis (baixo nível de evidência para o medicamento, comparado aos padronizados pelo SUS), tratamentos realizados, opções de tratamentos oferecidos pelo SUS,

Em razão do exposto este Núcleo de Apoio Técnico é desfavorável ao pedido de Aripiprazol, Oxalato de escitalopram e Levomepromazina.

No caso dos autos, **não há demonstração de que a decisão de não padronizar o(s) medicamento(s) seja ilegal, tampouco que tenha havido mora ou ausência de análise técnica**.

A respeito disso, destaco passagem do PDCT relacionado à esquizofrenia (fl.04 do PDCT):

As evidências não demonstraram superioridade, no tratamento da esquizofrenia de levomepromazina, pimozida, tioridazina, trifluoperazina, zuclopentixol, amisulprida, paliperidona, penfluridol e sulpirida. A pipotiazina pertence ao mesmo grupo farmacológico do haloperidol, não se evidenciando vantagem de sua utilização em relação ao haloperidol. Como medicamento *depot*, a flufenazina surge apenas como alternativa à utilização do haloperidol por pertencer a um grupo farmacológico diferente. A risperidona *depot* também não tem evidências que justifiquem sua inclusão neste Protocolo. O aripiprazol é muito semelhante em eficácia aos demais antipsicóticos em estudos de esquizofrenia em geral e, nos casos de esquizofrenia refratária, também não demonstrou superioridade em relação aos demais para justificar aqui sua inclusão (73,74,126).

No que se refere ao oxilato de escitalopram, do parecer do NAT, verifico que ele não é indicado para a doença que acomete a parte autora (fl. 35):

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 19/12/2025 às 16:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801055-39.2025.8.12.0010 e código 2pj09Ba2.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Fátima do Sul
2ª Vara

Oxalato de Escitalopram (princípio ativo) é um antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de serotonina (5-HT). A inibição da recaptação de 5-HT é o único mecanismo de ação provável que explica os efeitos farmacológicos e clínicos do escitalopram. O escitalopram não apresenta afinidade, ou esta é muito baixa, pelos receptores 5-HT1A, 5-HT2, DA D1 e D2, histamínicos H1, adrenérgicos alfa1-, alfa2- e beta, colinérgicos muscarínicos, benzodiazepínicos e opioides. É utilizado para tratar a depressão, com melhora dos sintomas de ansiedade relacionados a esta e, após a melhora, para prevenir a recorrência dos episódios depressivos. Trata também o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada (TAG) e o transtorno de ansiedade social, que também é chamado de fobia social. O efeito adverso mais comum é o enjoo, que na maioria dos casos desaparece até o final das duas primeiras semanas de uso. Outros efeitos adversos possíveis são: sinusite (nariz congestionado ou com coriza), diminuição do apetite, dificuldade para adormecer, sonolência, tonturas, bocejos, diarreia, constipação intestinal, sudorese aumentada, perturbações sexuais (demora na ejaculação, problemas de ereção, diminuição da libido; mulheres podem ter dificuldade em atingir orgasmo), cansaço, febre.

Ademais, **não foram apresentadas evidências científicas de alto nível (como ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas)**, sendo insuficiente, para esse fim, o simples laudo médico prescrevendo a medicação, conforme vedação expressa da tese fixada:

> *Não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação." (Tema 6, item 3, alínea "b")*

Portanto, quanto à *imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS*, **observa-se que o laudo médico carreado aos autos, limita-se à prescrição do tratamento, sem justificar de forma técnica, clínica e individualizada a imprescindibilidade absoluta do uso dos fármacos indicados, tampouco demonstra falha terapêutica documentada de alternativas ofertadas pelo SUS, sendo a improcedência da demanda a medida que se impõe.**

Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência:

> *DIREITO À SAÚDE - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS - **AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS** – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (*TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0806245-27.2023.8.12.0018, Paranaíba, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j: 27/01/2025, p: 29/01/2025)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 19/12/2025 às 16:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801055-39.2025.8.12.0010 e código 2pj09Ba2.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Fátima do Sul
2ª Vara

3. DISPOSITIVO

Isso posto, confirmo o indeferimento da tutela de urgência vindicada e julgo **improcedente** o pedido inicial formulado por **Raquel Costa dos Reis** em desfavor do **Estado de Mato Grosso do Sul**, qualificados.

Diante da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da gratuidade da justiça, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.

Em consequência disso, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com base no art. 487, inc. I, do CPC.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

Fátima do Sul, data da assinatura digital.

Mario Cesar Mansano
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 19/12/2025 às 16:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801055-39.2025.8.12.0010 e código 2pj09Ba2.